Врач-эндоскопист /_____ / ВЕРЕНЦОВА ТАТЬЯНА ФЕЛИКСОВНА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская многопрофильная больница № 2»,
Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5, тел.: 338-48-88
E-mail: b2@zdrav.spb.ru; b2@zdrav.gugov.spb.ru

КУЗЬМИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ , № МК 107574-26-С
12.05.1963 , муж
26.10.2026 08:05 ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Дата отмены: 26.10.2026 08:05; Причина отмены: выполнено ранее.

ЛЕВЧЕНКО Е.И. / 26.10.2026 08:05

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская многопрофильная больница № 2»,
Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5, тел.: 338-48-88
E-mail: b2@zdrav.spb.ru; b2@zdrav.gugov.spb.ru

КУЗЬМИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ , № МК 107574-26-С
12.05.1963 , муж
26.10.2026 11:52 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ВНУТРИВЕННЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ

Информация об оборудовании:
Название устройства: Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM Aera
Инвентарный номер: 1378420
Серийный номер: 142522
Модель: MAGNETOM Aera

Описание исследования
Дата проведения исследования: 26.10.2026 14:08
Цель исследования: рецидив Шванномы?
Описание результатов
Выполнена серия МР-томограмм головного мозга (FLAIR, T2ВИ, T1ВИ, DWI), в том числе после внутривенного контрастного усиления (Омнискан).
В анамнезе удаление шванномы преддверно-улиткового нерва в области левого мостомозжечкового угла от 2013 г. с частичной резекцией лицевого нерва; радиохирургическое лечение от 2017 г.; повторное микрохирургическое удаление опухоли от 2024 г. (рецидив). По данным МРТ от 25.06.2026 описан интракраниальный участок накопления контрастного вещества без динамики по сравнению с исследованием от 2025 г. Предыдущие исследования на момент описания не представ-лены.
Видимые отделы спинного мозга на уровне С1–С2 утолщены. В правой половине спинного мозга определяется участок изменённого МР-сигнала с ограничением диффузии на DWI, характерного для ишемии, размерами около 33×12 мм в сагиттальной плоскости.
Желудочковая система расширена. Боковые желудочки асимметричны, индекс Эванса 0,32. III желудочек шириной 13 мм. Перивентрикулярно определяются зоны глиоза. Цистерны основания мозга расширены. Мостомозжечковая цистерна и IV желудочек расширены, IV желудочек до 37×31 мм. Наружные субарахноидальные пространства не расширены, хорошо дифференцируются над

обоими полушариями.
Слева определяется состояние после ретросигмовидной краниотомии. В области оперативного вмешательства, в проекции послеоперационно изменённого левого внутреннего слухового прохода, определяется мягкотканное образование активно накапливающее парамагнетик. Над левой гемисферой мозжечка определяется арахноидальная киста размерами около 64×25 мм. В мосту мозга, больше справа, определяется зона диффузных изменений МР-сигнала, наиболее вероятно обусловленных компрессией расширенными ликворными пространствами.
В остальных отделах вещества головного мозга участков ограничения диффузии не выявлено. Патологического накопления контрастного вещества в веществе и оболочках мозга, помимо описанного, не определяется.
Срединные структуры не смещены. Миндалины мозжечка расположены на обычном уровне. Гипофиз не увеличен.
В правой верхнечелюстной пазухе определяется киста размерами до 39×31 мм.

Заключение
МР-признаки утолщения спинного мозга на уровне С1–С2 с участком ограничения диффузии в правой половине размерами около 33х12 мм - наиболее вероятно, очаг ишемии спинного мозга. МР-признаки внутренней гидроцефалии (индекс Эванса 0,32), вероятно обусловленной нарушением ликвороттока на уровне краниовертебрального перехода вследствие утолщения спинного мозга. Состояние после ретросигмовидной краниотомии слева, повторного удаления шванномы преддверно-улиткового нерва и радиохирургического лечения. МР-признаки мягкотканного образования в области оперативного вмешательства, накапливающего контрастное вещество (остаточная опухолевая ткань / продолженный рост). Арахноидальная киста задней черепной ямки слева. Киста правой верхнечелюстной пазухи.
Рекомендации: консультация невролога и нейрохирурга в неотложном порядке.

Врач-рентгенолог /_____ / МЕРКУЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская многопрофильная больница № 2»,
Санкт-Петербург, Учебный пер., д. 5, тел.: 338-48-88
E-mail: b2@zdrav.spb.ru; b2@zdrav.gugov.spb.ru

КУЗЬМИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, № МК 107574-26-С
12.05.1963, муж

27.10.2026 10:05 ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

Наименование дополнительного исследования: Электрокардиография;
Электрокардиограмма
Номер исследования: 7492; электрокардиограф ЭК 12Т-01-Р-Д/260;
ЧСС: 61 уд/мин;
Ритм: синусовый;
Положение ЭОС: горизонтально расположена;

RR интервалы:
Минимальный RR интервал - 0,96 с;
Максимальный RR интервал - 1,02 с;

Длительность элементов комплекса PQRST:
Интервал P: 0,12 с;
Интервал PQ: 0,18 с;
Комплекс QRS: 0,1 с;
Интервал QT: 0,36 с;

Заключение
Синусовый ритм со средней ЧСС 61 уд/мин. Горизонтальное положение ЭОС. Межпредсердная блокада 1 ст. Местные нарушения в/желудочкового проведения. ГЛЖ. ;